

Handlungsschritte mit der kombinierten Handschuh- und Pinzettenmethode beim Mann

Prinzip:

Unbedingte aseptische und atraumatische Vorgehensweise, Indikation zur Legung eines transurethralen Katheters stellt der Arzt. Die transurethrale Katheterisierung ist ein Eingriff in den Intimbereich und sollte wenn möglich von einer Pflegeperson gleichen Geschlechts durchgeführt werden. Vor dem Legen des Katheters ist eine Genitalreinigung durchzuführen.

1. Patienten informieren
2. Abwurf bereit stellen
3. Wischdesinfektion Arbeitsplatz
4. Händedesinfektion
5. Urinableitungssystem auspacken und so am Bett anbringen, dass unteres Ableitungsventil nicht mit dem Boden in Berührung kommt. Konnektionsstelle des Schlauches muss in greifbarer Nähe deponiert werden (evt. unter Matraze fixieren). Verschlußkappe der Konnektionsstelle darf dabei nicht entfernt werden.
6. Lagerung des Patienten: Rückenlagerung, flache oder leichte Oberkörperhochlagerung (unproblematische Sicht auf die Harnröhrenöffnung), evtl. bei Prostatahypertrophie kleines Kissen unter das Becken legen. Beine möglichst gespreizt: Fersenabstand: ca. 50 cm. Zum Bettschutz kann eine Moltexunterlage unter das Gesäß gelegt werden.
7. Katheterset öffnen (z.B. auf dem Nachtschränkchen), das Einschlagtuch dabei als sterile Arbeitsfläche belassen.
8. Sterile Unterlage zwischen den Beinen des Patienten ausbreiten, so daß eine sterile Fläche entsteht. (Bei unruhigen Patienten immer mit zwei Pflegekräften katheterisieren)
9. Katheter und Gleitmittel vorsichtig auf die sterile Fläche fallen lassen.
10. Desinfektionsmittelflasche öffnen.
11. Einen sterilen Handschuh anziehen, mit der sterilen Hand den anderen Handschuh und das Schlitztuch neben die Nierenschale legen, die Blockerspritze auf die sterile Fläche beim Patienten legen.
12. Tupfer in der Nierenschale mit dem Schleimhautdesinfektionsmittel übergießen (Tupfer sollen gut getränkt sein); vorher den ersten Tropfen ausgießen und werfen.
13. Zweiten sterilen Handschuh anziehen.
14. Lochtuch mit dem Schlitz über die Genitalregion legen, Penis und damit Harnröhrenöffnung bleiben frei. ***Dabei die sterilen Handschuhe nicht unsteril machen.***
15. Katheter ganz auspacken, (längs perforierte Öffnungsschiene) und wieder auf die sterile Fläche ablegen, Instillagel öffnen.

16. Die linke Hand (beim Rechtshänder) streift die Vorhaut zurück und hält den Penis senkrecht nach oben. **Diese Hand ist ab diesem Handlungsschritt nicht mehr steril.**
17. Desinfektion der Eichel mit der rechten Hand (mit einer Pinzette):
 - **für jeden Desinfektionsweg neuen Tupfer verwenden!**
 - **gebrauchte Tupfer nicht mit sterilem Katheter und ungebrauchten Tupfern in Berührung bringen!**
 - Desinfektion der Harnröhrenöffnung
 - In geraden o. kreisenden Bewegungen von der Harnröhrenöffnung weg desinfizieren.
 - Desinfektion der Eichelfurche.
 - Zum Schluss nochmals die Harnröhrenöffnung desinfizieren, in dem diese etwas gespreizt wird.
 - (Pinzette verwerfen)
18. Einbringen des Gleitmittels (Instillagel):
 - Gegen den ersten Widerstand die Spritze entlüften (Stempel der Instillagel-Spritze ist immer etwas verklebt).
 - Zuerst einen Tropfen Instillagel auf die Harnröhrenöffnung aufbringen und dann den Spritzenkonus in die Harnröhre einführen.
 - Den gesamten Inhalt langsam in die Harnröhre spritzen.
 - Penis in der Eichelfurche komprimieren, so dass das Gleitmittel nicht wieder herausläuft.
 - Mindestens 2 min. warten, bis das Lokalanaesthetikum im Gleitmittel wirkt.
19. Penis möglichst nicht mehr ablegen, falls doch notwendig, auf die im Set befindliche Komresse legen.
20. Katheterspitze mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand greifen und den Katheter in einer Schlaufe über den Handrücken führen. Das Ende zwischen Ring- und Kleinfingerseite umfassen. (Alternativ kann der Katheter mit der zweiten Pinzette eingeführt werden).
21. Katheter vorsichtig einführen. Keine Gewalt anwenden! Bei Auftreten eines Widerstandes genügt oft eine kleine Drehung. Penis bleibt dabei gestreckt (curvatura praepupica). Nach 10 - 15 cm wird ein leichter Widerstand gespürt (curvatura infrapubica) und der Penis wird in eine waagerechte Position gebracht ohne ihn abzulegen. Der Katheter wird weiter geschoben bis Urin in die Nierenschale fließt. **Danach wird der Katheter noch weitere 5 - 7 cm vorgeschoben, damit der Blockungsballon sicher in der Blase liegt.**
22. Der Katheter wird abgekniffen oder in die Ablaufschale gehalten und das Harnableitungssystem angeschlossen. Dabei darf der Katheter nicht versehentlich aus der Blase entfernt werden.
23. Der Katheter wird mit Hilfe der bereitgelegten Blockerspritze und der vorgesehenen Füllmenge geblockt. (auch vor dem Anschluß an das Ableitungssystem möglich). **Dabei auf Widerstand und Schmerzäußerungen des Patienten achten.**
24. Der Katheter wird vorsichtig bis zum Widerstand des Blockungsballons zurückgezogen.
25. Die Vorhaut muss nun wieder über die Eichel gestreift werden, da sonst die Gefahr einer **Paraphimose** besteht: Durch das Zurückstreifen einer zu engen Vorhaut über die Eichel kann es zur Bildung eines Schnürringes kommen. Es entsteht eine Stauungsschwellung der Eichel und ein Vorhautödem. Wird dieser Zustand nicht rechtzeitig durch eine mechanische Reposition oder einen chirurgischen Schnitt beseitigt, kann es zum Absterben der Vorhaut und der Eichel kommen.

Handlungsschritte mit der kombinierten Handschuh- und Pinzettenmethode bei der Frau

Schritte 1-13 wie beim Mann

14. Lochtuch mit dem Schlitz über die Genitalregion legen, so daß die Vulva gut sichtbar und zugänglich ist. ***Dabei die sterilen Handschuhe nicht unsteril machen.***

15. Katheter ganz auspacken, (längs perforierte Öffnungsschiene) und wieder auf die sterile Fläche ablegen, ggf. Instillagel öffnen.

16. Die linke Hand (beim Rechtshänder) spreizt die Labien mit leichtem Zug nach oben, so daß die kleinen Labien und die Harnröhrenöffnung einsehbar sind. ***Diese Hand ist ab diesem Handlungsschritt nicht mehr steril. Die Spreizung der Labien darf bis zum Ende des Katheterisierungsvorgangs nicht mehr aufgehoben werden.***

17. Desinfektion mit der rechten Hand und einer sterilen Pinzette. (Grundsätze wie beim Mann)

- Wischdesinfektion der großen und kleinen Labien rechts und links von der Symphyse in Richtung Anus. (große und kleine Labien in getrennten Arbeitsschritten).
- Desinfektion des Scheidenvorhofs: Bei Patientinnen mit Fluor kann der getränkte Tupfer während des Katheterisierens vor dem Scheideneingang liegenbleiben.
- Zum Schluss Desinfektion der Harnröhrenöffnung.

18. Ggf. Harnröhre mit Instillagel anaesthetisieren.

19. und 20. wie beim Mann.

21. Katheter vorsichtig einführen: Keine Gewalt anwenden! Bei Auftreten eines Widerstandes genügt oft schon eine kleine Drehung der Katheterspitze, um aus einer Schleimhautfalte wieder herauszukommen.

22. Katheter wird eingeführt, bis Urin fließt. ***Danach wird der Katheter weitere 5 - 7 cm vorgeschoben, damit der Blockungsballon sicher in der Blase liegt.***

Schritte 23 - 25 wie beim Mann.

Nachbereitung:

- Ungehinderten Abfluss des Urins überprüfen. Es muss darauf geachtet werden, dass kein Zug auf den Katheter ausgeübt wird. Katheterschlauch dafür ggf. am Bett oder Patient befestigen.
- Desinfektions- und Gleitmittelreste beim Patienten mit Kompressen und Abdecktuch entfernen.
- Materialien aus dem Bett entfernen und entsorgen.
- Patienten lagern, zudecken, Befinden erfragen.
- Aufräumen des Zimmers und des Bettplatzes.
- Dokumentation (Legedatum, Kathetergröße, Blockungsvolumen, Besonderheiten)